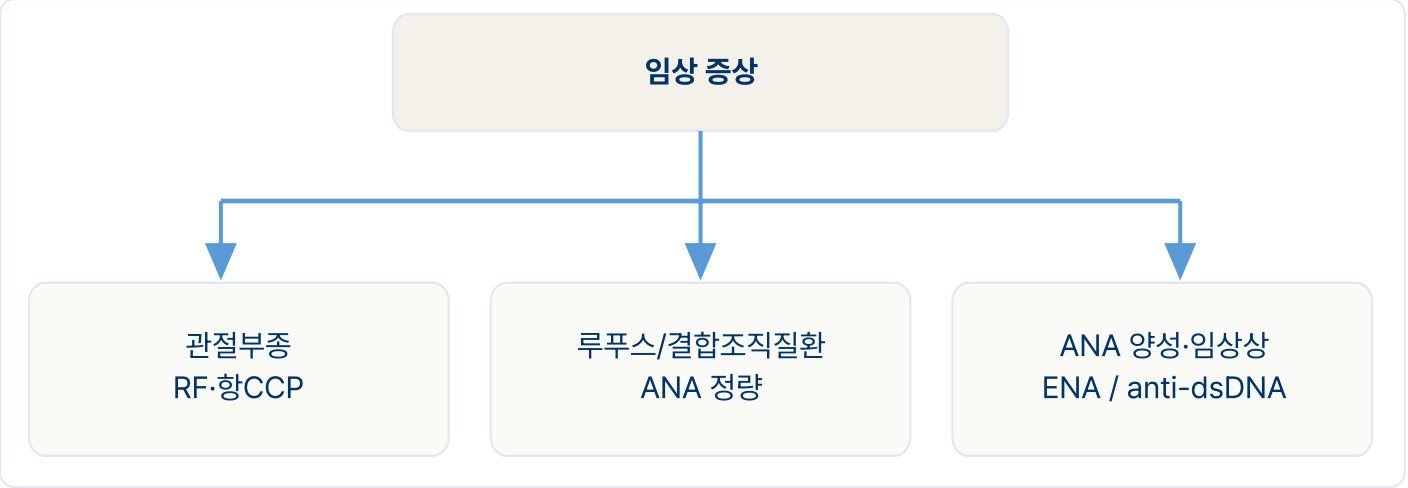
자가항체 검사 먼저 의심 질환을 정합니다

선별 패널보다 증상에 맞춘 검사 주문



관절부종 → RF·항CCP

명확한 활막염에서 두 검사를 활용합니다. ANA는 발진·구강궤양·레이노·관절염 등 결합조직질환이 의심될 때 정량(역가)으로 주문합니다. ANA 정성만으로 판단하지 않습니다.

ANA 양성 → 추가 검사

임상상에 맞춰 anti-dsDNA·ENA를 선택합니다. ANA 음성이라도 쇼그렌 의심 시 anti-Ro 검사에 의미가 있습니다. ENA 양성에서는 연관 질환 평가를 위해 류마티스내과 의뢰를 고려합니다.

추적 검사의 목적

ENA 역가를 활동도 지표로 반복 추적하지 않습니다. Anti-dsDNA는 루푸스, 특히 신염의 활동도와 연관되어 추적할 수 있습니다. 홍석찬 연자 Q&A: 증상 없는 ANA 1:80은 굳이 추적하지 않습니다.

ANA·ENA 해석과 추적

질병 연관 항체와 활동도 항체를 구분

ANA 역가

건강인 양성률: ≥1:40 20~30%, ≥1:80 10~12%, ≥1:160 5%, ≥1:320 3%.
강의에서는 보통 ≥1:160을 임상적으로 의미 있는 역가로 소개했습니다. 패턴은 검사자·방법 차이가 있어 역가와 임상상, 필요시 ENA를 더 중시합니다.

위양성과 위음성

갑상선·간질환·감염·악성종양에서도 ANA 양성일 수 있습니다. 고역가도 수년~수십 년 무증상일 수 있어 양성만으로 질환을 확정하지 않습니다. HEp-2 처리 과정의 항원 소실 또는 세포질 항원 때문에 음성일 수 있으며 쇼그렌 의심 시 anti-Ro를 따로 봅니다.

ENA의 질병 연관

Sm: SLE 특이도 높음. RNP: MCTD·중첩 증후군. Ro/La: 쇼그렌·SLE·신생아루푸스/선천성 심장차단 연관. Jo-1: 염증성 근염. Scl-70: 전신경화증·폐섬유화. Centromere: 제한피부형 전신경화증·폐고혈압. RNA polymerase III: 미만피부형·신장 침범. Histone: 약물유발 루푸스. 항인지질항체: 혈전·태아소실·혈소판감소.

홍석찬 연자 Q&A · 반복 측정

임상상 변화 시 항CCP 역가 추적을 고려할 수 있으나 반복 측정은 급여 불가라고 답했습니다. RF·항CCP 동시검사와 ANA 정량 직접 주문에서 삭감 경험이 없었다는 답변은 연자의 경험입니다.

급여와 다른 검사 주문의 맥락

강의에서 소개한 기준·연자 Q&A

강의 소개 · 누785 ENA 급여

누784 ANA 또는 누784-1 ANA(항DNA 포함) 양성인 경우 인정. 예외로 근염 의심 시 누785가 anti-Jo-1, 루푸스/쇼그렌 의심 시 누785라 SS-A(Ro)·누785마 SS-B(La)를 소개했습니다. 연자는 예외의 의심 맥락과 삭감 경험을 함께 설명했습니다.

ANCA · 전신 혈관염 의심

혈뇨·단백뇨+발열/CRP 상승 등 전신 염증에서 고려합니다. p-ANCA는 MPO, c-ANCA는 PR3와 연결됩니다. GPA/MPA/EGPA는 모두 양성인 것은 아니며 ANCA 단독 양성은 진단이 아닙니다. 감염·심내막염·IBD·암·hydralazine/PTU 등에서도 양성일 수 있습니다.

HLA-B27 · 인구 선별 금지

염증성 요통, 천장관절염, 무릎·발목 관절염, 아킬레스 부착부염, 건선·IBD·포도막염 맥락에서 주문합니다. 발병 <40세, >3개월 요통, 서서히 시작, 아침/밤 악화와 운동 시 호전이 단서입니다. 양성자의 SpA 발생 위험은 약 2~10%(약 5%)로 소개했습니다.

홍석찬 연자 Q&A · 반복 포도막염

다른 증상이 뚜렷하지 않아도 HLA-B27·천장관절 X-ray가 도움될 수 있습니다. HLA-B51은 베체트병 민감도 약 50%, 일반인 양성 10~20%라 진단 가치가 낮습니다. 급여 삭감 경험이 없다는 답은 연자의 경험으로 제시했습니다.